RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MELAKUKAN BRONCHIAL WASHING DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1229/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan untuk membantu mengencerkan sekresi yang terdapat pada dinding broncus dengan menggunakan cairan Nacl 0,9 %, pada pasien yang menggunakan ETT dan TT.
TUJUAN	1. Membantu mengencerkan sputum yang kental, serta mempermudah pengeluaran sputum dari paru-paru. 2. Mengurangi penumpukan CO2 di paru sehingga mencegah penyempitan saluran napas. 3. Mencegah terjadinya broncopnemonia Memperlancar sirkulasi dan perfusi ke seluruh jaringan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1.Beritahu prosedur tindakan pada pasien 2.Mencuci tangan/ pakai sarung tangan 3.Lakukan observasi terhadap tanda vital pasien meliputi saturasi, nadi, pernafasan, Tekanan darah serta monitor EKG bila perlu. 4.Berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi melalui air viva, serta posisikan pasien duduk/ setengah duduk 5.Tuangkan NACL 0,9% ke dalam mangkok yang steril secukupnya lalu hisap dengan spuit 10 cc. 6.Semprotkan melalui ETT/TT sebanyak 5 cc , dan lakukan pemompaan dengan air viva beberapa kali supaya cairan menyebar sampai bagian- bagian broncus. 7.Buat posisi drainage (bila memungkinkan) atau dibatukkan, sambil secepatnya dilakukan penghisapan. 8.Berikan lagi oksigen konsentrasi tinggi melalui viva. 9.Prosedur bisa diulangi sampai benar-benar bersih/

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MELAKUKAN BRONCHIAL WASHING DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1229/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 2/2
	sputum banyak bekurang. 10.Pada penghisapan terakhir kita kempeskan cuff (balon ETT), lama pemasangan cuff sama dengan type pernafasan pada ventilator. 11.Setelah prosedur selesai cuff diisi kembali secukupnya. 12.Mencuci tangan 13.Evaluasi respon pasien terhadap tindakan.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive		